



ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีการรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหุดหทัยใจขณะหลับและมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ ๑๔) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (ข) ของข้อ ๕ (๒) แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(ข) การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหุดหทัยใจขณะหลับ ให้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์และค่าอุปกรณ์ ดังนี้

(๑) ค่าตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ ๑ (มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจทั้งคืน) จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ ๒ (การตรวจวัดเหมือนการตรวจชนิดที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจ) จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Positive Airway Pressure : PAP) และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษา

ทั้งนี้ ในการให้บริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนและการจ่ายค่าอุปกรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ข้อ ๓ กรณีสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน เป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและจัดหาอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก หน้ากากครอบจมูกหรือปากในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน หรือส่งผู้ประกันตนไปเข้ารับการรักษายังสถานพยาบาลอื่น ให้สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ พร้อมค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่สถานพยาบาลอื่นที่ทำการรักษา และนำมายื่นขอรับค่าบริการทางการแพทย์ พร้อมค่าอุปกรณ์ต่อสำนักงาน ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์ที่สำนักงานกำหนดตาม ข้อ ๒

ข้อ ๔ ให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าและหน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้รับสิทธิการเบิกเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าและหน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้าต่อไปจนครบตามสิทธิ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายสุรเดช วลีอิทธิกุล)

ประธานกรรมการการแพทย์

หลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ
ท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรา
สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน
ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. หลักเกณฑ์ในการประเมินก่อนส่งตรวจวินิจฉัยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Polysomnography) ให้มีการบันทึกของแพทย์ผู้ส่งตรวจในเวชระเบียน ประกอบด้วย

๑.๑ การซักประวัติ สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยละเอียด เช่น ประวัติการนอน การกรน การสังเกตเห็นการหยุดหายใจ (witnessed apnea) การตื่นขึ้นมาสำลัก (nocturnal choking หรือ gasping) การนอนกระสับกระส่าย (restlessness) และการง่วงนอนมากผิดปกติช่วงกลางวัน รวมทั้งสอบถามประวัติเกี่ยวกับสุขอนามัยการนอนหลับของผู้ประกันตนที่ป่วย โรคประจำตัว รวมถึงความผิดปกติของการนอนหลับอื่นๆ ที่อาจพบร่วมด้วย

๑.๒ การตรวจร่างกาย โดยตรวจหาลักษณะที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรค Obstructive Sleep Apnea ได้แก่ ความดันโลหิต น้ำหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวลกาย ความยาวเส้นรอบคอ ความยาวรอบเอว โครงสร้างศีรษะและใบหน้า เช่น คางเล็ก ฟันสบผิดปกติ ลักษณะทางเดินหายใจ เช่น จมูก ช่องปาก ทอนซิล ลิ้นไก่ เพดานอ่อน ระบบประสาท ระบบหลอดเลือดหัวใจ เพื่อประเมินโรคที่อาจเกิดร่วมกันหรือเกิดขึ้นตามหลังปัจจัยเสี่ยงของโรค (Obstructive Sleep Apnea)

๑.๓ มีคะแนนประเมินความเสี่ยงโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น จากแบบประเมิน Stop - Bang ≥ 5

๑.๔ กรณีนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับเป็นผู้พิจารณาความจำเป็น

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ หรือเป็นกลุ่มเป้าหมายตามข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๔ โดยให้เข้ารับการตรวจการนอนหลับชนิดที่ ๑ และชนิดที่ ๒ ในสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์

๒. คุณสมบัติของแพทย์ผู้ส่งตรวจ Polysomnography ต้องเป็นแพทย์ที่รายงานผลตรวจการนอนหลับและแพทย์ผู้สั่งเบิกเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกรวมทั้งหน้ากากครอบจมูกหรือปาก ให้แก่ผู้ประกันตนได้ในกรณีดังต่อไปนี้

๒.๑ ในกรณีที่สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การนอนหลับ ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับที่สามารถรายงานผลตรวจการนอนหลับครั้งนี้เป็นผู้ส่งตรวจ

- (๑) อายุรแพทย์การนอนหลับ
- (๒) กุมารแพทย์การนอนหลับ
- (๓) โสต ศอ นาสิกการนอนหลับ
- (๔) จิตแพทย์การนอนหลับ

๒.๒ ในกรณีที่สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิ ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์การนอนหลับ ให้แพทย์สาขาดังนี้ สามารถส่งตรวจได้ตามความเหมาะสม

- (๑) อายุรแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ สาขาประสาทวิทยา
- (๒) กุมารแพทย์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ สาขาประสาทวิทยา
- (๓) โสต ศอ นาสิก

๓. สำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับ ให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิ ดังนี้

๓.๑ ค่าตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ ๑ (มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจทั้งคืน) จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท

๓.๒ ค่าตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ ๒ (การตรวจวัดเหมือนการตรวจชนิดที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจ) จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท

๓.๓ ค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Positive Airway Pressure : PAP) และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาในอัตราที่สำนักงานกำหนด ดังนี้

รหัส อุปกรณ์	ประเภท	หน่วย	ราคา (บาท)
๓๐๑๒	เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (Positive Airway Pressure : PAP) ลักษณะ เป็นเครื่องเพิ่มความดันอากาศในทางเดินหายใจ เพื่อให้ความดันอากาศในทางเดินหายใจเป็นบวกตลอดเวลา สามารถปรับแรงดันได้ ใช้ร่วมกับหน้ากากครอบจมูกหรือปาก แต่ละชุดประกอบด้วยตัวเครื่องหน้ากาก ท่อต่อและอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วนพร้อมใช้งานได้ ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ประกันตนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ที่รักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลหรือไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อน หรือผ่าตัดแล้วไม่ได้ผล โดยผู้ประกันตนต้องผ่านการประเมินด้วยการตรวจวินิจฉัยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Polysomnography) และมีเอกสารรายงานผลว่าผู้ประกันตนผ่านการทดลองการยอมรับการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเฉลี่ยอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง/คืน (โดยรวมคำนวณทุกคืน) เป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ หรือ ๒ สัปดาห์ในเครื่องแรก หรือกรณีเป็นเครื่องถัดไปให้มีการทดลองใช้เครื่องใหม่ว่าผู้ประกันตนผ่านการทดลองการยอมรับการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเฉลี่ยอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง/คืน (โดยรวมคำนวณทุกคืน) ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย ๔ สัปดาห์ ร่วมกับมีเอกสารหลักฐานยืนยันว่าเครื่องเดิมชำรุด ก่อนทำการส่งมอบเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเครื่องถัดไป ทั้งนี้ ต้องมีระดับความรุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ๑. มีระดับความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นระดับมาก (ดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว (Apnea-Hypopnea Index, AHI)) ≥ 30 ครั้ง/ชม.) ๒. มีระดับความรุนแรงของโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นระดับปานกลาง (ดัชนีการหยุดหายใจและหายใจแผ่ว (Apnea-Hypopnea Index, AHI)) = ๑๕-๒๙ ครั้ง/ชม.) และเป็นโรคเกี่ยวกับโรคสมองขาดเลือด (Stroke) หรือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial infarction) หรือภาวะหัวใจล้มเหลว หรือ Refractory HT (ผู้ป่วยที่มี SBP/DBP มากกว่า หรือเท่ากับ ๑๔๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท ในขณะที่ได้รับยาลดความดันโลหิตมากกว่า หรือเท่ากับ ๓ กลุ่ม)	ชุดละ	๒๐,๐๐๐

รหัส อุปกรณ์	ประเภท	หน่วย	ราคา (บาท)
	คุณสมบัติและลักษณะของอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ๑. สถานพยาบาลต้องจัดหาเครื่องที่มีการรับประกันตัวเครื่อง ๕ ปี ขึ้นไป หากเครื่องชำรุดสถานพยาบาลต้องดำเนินการรับผิดชอบซ่อม/เปลี่ยนเครื่องให้ผู้ประกันตน ๒. ต้องเป็นเครื่องที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ๓. เป็นเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ระดับแรงดัน ๑ ระดับ หรือ ๒ ระดับ หรือแบบอัตโนมัติ ๔. สามารถคำนวณและออกบันทึกผลการใช้เครื่องขณะให้การรักษาด้วยแรงดันบวกเป็นร้อยละของจำนวนวันที่ใช้ได้เฉลี่ย ๔ ชั่วโมง/วัน ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ๕. บริษัทที่จำหน่ายเครื่องต้องมีระบบติดตามผลและให้ความรู้แก่ผู้ประกันตน (PAP Education)		
๓๐๑๓	หน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ทั้งนี้ ในการเบิกจ่ายหน้ากากครอบจมูกหรือปาก ที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (ในครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป) ประกอบด้วยทุกข้อดังต่อไปนี้ ๑. ในกรณีที่ใช้ทดแทนกรณีหน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ ให้เบิกได้ไม่เกิน ๑ ชิ้น/ปี ๒. แนบเอกสารยืนยันว่ามีการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกเฉลี่ยอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง/วัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ในระหว่างที่มีการใช้งานอย่างน้อย ๓ เดือน	ชิ้นละ	๔,๐๐๐

ทั้งนี้ ค่าอุปกรณ์เสริม รายการแผ่นกรองอากาศ (Filter) กระดาษ และแผ่นกรองอากาศ (Filter) ฟองน้ำ ให้รวมอยู่ในค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน

๓.๔ คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกและหน้ากากครอบจมูกหรือปาก จะต้องเป็นแพทย์ ดังต่อไปนี้

(๑) อายุรแพทย์การนอนหลับ หรือโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต หรือโรคระบบการหายใจ สาขาประสาทวิทยา

(๒) กุมารแพทย์การนอนหลับ หรือโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต หรือโรคระบบการหายใจ สาขาประสาทวิทยา

(๓) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิก อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา

(๔) จิตแพทย์การนอนหลับ

๓.๕ คุณสมบัติของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับที่สามารถรายงานผลตรวจการนอนหลับ จะต้องเป็นแพทย์ ดังต่อไปนี้

(๑) แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติการนอนหลับจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์หรือกุมารแพทย์ หรือโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

(๒) แพทย์ที่ผ่านการสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย

(๓) แพทย์ที่ผ่านการสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การนอนหลับหรือเทียบเท่า หลักสูตรอย่างน้อย ๑ ปี จากสถาบันฝึกอบรมหรือสมาคม หรือราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

๔. กรณีแพทย์ประเมินว่าผู้ประกันตนมีความจำเป็นต้องได้รับอุปกรณ์ชนิดที่เหมาะสมกับผู้ประกันตน ให้สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิจัดหาเครื่องที่มีมาตรฐานและเหมาะสมตามที่แพทย์พิจารณา และมีให้เรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มจากผู้ประกันตน เว้นแต่กรณีเป็นความต้องการของผู้ประกันตนให้ผู้ประกันตนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากสิทธิ

๕. ให้สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิเป็นผู้ตรวจวินิจฉัยและจัดหาเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกและหน้ากากครอบจมูกหรือปาก ให้กับผู้ประกันตนภายในระยะเวลา ๑ เดือน กรณีเกินศักยภาพให้สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิส่งตัวผู้ประกันตนไปยังสถานพยาบาลระดับสูง หรือสถานพยาบาลที่มีศักยภาพซึ่งผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องในการให้บริการตามที่สำนักงานกำหนด

๖. กรณีที่ผู้ประกันตนเข้ารับบริการทางการแพทย์กรณีตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับในสถานพยาบาลที่มีศักยภาพซึ่งผ่านการรับรองจากราชวิทยาลัยหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง และสถานพยาบาลได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน โดยผู้ประกันตนไม่ได้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิ ให้สถานพยาบาลที่มีศักยภาพดังกล่าวจัดทำรายงานข้อมูลส่งมายังสำนักงานเพื่อเบิกจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ได้ตามอัตราที่ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กรณีมีค่าบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมจากอัตราที่ประกาศกำหนด ให้ผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ส่วนเกินแก่สถานพยาบาลที่มีศักยภาพดังกล่าว

แนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล

กรณี ผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับและจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า

สำนักสารสนเทศบริการสุขภาพ
25 กันยายน 2567

การบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาฯ นี้ เป็นแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีการรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับและมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure : CPAP) (22 ม.ค. 67) สกส. ในฐานะหน่วยงานที่รับข้อมูลการเบิกจ่าย ขอกำหนดแนวการเบิกค่ารักษาฯ ดังนี้

1. ข้อกำหนดในการส่งข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาล

การตรวจวินิจฉัย Polysomnogram เป็นการกรอผู้ป่วยในภาวะนอนหลับ ซึ่งต้องจัดบริการให้ผู้ป่วยนอนในสถานพยาบาล ตลอดระยะเวลาตรวจ การนอนพักค้างคืนในห้องตรวจของสถานพยาบาลเป็นส่วนประกอบของการตรวจ ไม่ใช่ ส่วนของการรับเป็นผู้ป่วยใน ในการเบิกค่ารักษาในกรณีนี้ ให้ถือว่า เป็นกรณีผู้ป่วยนอก

แนวทางการเบิกจ่ายการตรวจวินิจฉัยในกรณีต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้

- (1) กรณีการตรวจวินิจฉัยปกติ ให้เบิกจ่ายเป็นกรณีผู้ป่วยนอก ไม่มีการรับเป็นผู้ป่วยใน และไม่ส่งเบิกเป็นกรณีผู้ป่วยใน
- (2) กรณีการตรวจวินิจฉัยนี้ ในระหว่างรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยภาวะโรคหรือความจำเป็นในทางการแพทย์อื่น จะไม่ สามารถเบิกค่าตรวจวินิจฉัย Polysomnogram ได้ แต่หากผลการตรวจเป็น Positive สถานพยาบาลสามารถนำผลการตรวจนี้ เป็นหลักฐานการเบิกเครื่อง CPAP ได้
- (3) การตรวจวินิจฉัย Polysomnogram จะไม่สามารถเบิกซ้ำได้ภายในเวลา 3 ปี

ผู้ประกันตนที่เคยได้รับการตรวจการนอนหลับ ครั้งที่ 1 แล้วผลการตรวจการนอนหลับมีระดับความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งดูจาก Apnea-hypopnea Index (AHI) ที่ได้จากการวัดด้วยวิธี Full polysomnography ที่ไม่เข้าเกณฑ์ จะสามารถดำเนินการตรวจในครั้งถัดไปได้ โดยมีระยะเวลาห่างจากครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลายาวอย่างน้อย 3 ปี

กรณีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับตามที่ประกาศกำหนดประเมินว่าผู้ประกันตนมีภาวะเสี่ยงหรือเหตุผลความจำเป็นทางการแพทย์สมควรได้รับการตรวจก่อนครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี ให้พิจารณาเป็นรายกรณีไป โดยต้องผ่านตามความเห็นชอบจากคณะกรรมการการแพทย์หรือผู้ที่คณะกรรมการแพทย์มอบหมาย ทั้งนี้ สถานพยาบาลสามารถส่งเอกสารเพื่ออุทธรณ์ได้ผ่าน web ตามข้อ 3

2. การแจ้งรายชื่อแพทย์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ

- แพทย์ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ทำการยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนและวิธีการที่แจ้งในเอกสารหมายเลข CHI67-A02 แนวทางการยืนยันตัวตนของแพทย์ด้วย ThaID ผ่าน Application Line

3. การส่งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ

การเบิกการตรวจ Polysomnography และเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า/หน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า สถานพยาบาลจะต้องส่งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง สกส. สถานพยาบาลปฏิบัติดังนี้

- แจ้งส่งเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่ <https://cs5.chi.or.th/ssop/vfdoc.asp>
- วิธีการกรอกข้อมูลและส่งเอกสาร สามารถศึกษาได้จากคู่มือที่แสดงในหน้าเวปที่ส่งเอกสาร
- สำหรับรายการที่ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆ ผ่านแล้ว สกส. จะออกเลขที่กำกับการเบิก สถานพยาบาลนำเลขที่กำกับการ ไประบุในธุรกรรม SSOP รายละเอียดตามที่แจ้งในข้อ 4



4. การบันทึกข้อมูลเพื่อเบิกค่ารักษา

ให้สถานพยาบาลบันทึกข้อมูลเบิกค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบ SSOP รุ่น 0.93 เป็นต้นไป การบันทึกข้อมูลให้บันทึกข้อมูลเหมือนกรณีผู้ป่วยนอกทั่วไป และบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

- ระบุ "STCPAP" ใน BillTran.AuthCode
- ระบุ เลขที่กำกับการเบิก ที่ได้จากข้อ 3. ใน OPServices.SvTxCode

กรณีเบิกค่า Polysomnogram

- ระบุรหัสเบิกและอัตราตามตารางที่ 1. ใน <BillItems>
- ระบุ "OPF" ใน BillItems.ClaimCat

กรณีเบิกเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP)

- ระบุรหัสเบิกและอัตราตามตารางที่ 2. ใน <BillItems>
- ระบุ "OPF" ใน BillItems.ClaimCat
- แพทย์ผู้รับรองผลการตรวจ Polysomnogram แพทย์ผู้สั่งจ่ายเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ใน <OPServices>
 - ระบุ "ED" (Class ใหม่ = Endorser) ใน OPServices.Class
 - ระบุเลขที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใน OPServices.SvPID

กรณีเบิกหน้ากากครอบจมูก

- ระบุรหัสเบิกและอัตราตามตารางที่ 3. ใน <BillItems>
- ระบุ "OPF" ใน BillItems.ClaimCat
- แพทย์ผู้สั่งจ่ายหน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ใน <OPServices>
 - ระบุ "ED" (Class ใหม่ = Endorser) ใน OPServices.Class
 - ระบุเลขที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ใน OPServices.SvPID

ตารางที่ 1 รหัสและอัตราการเบิก Polysomnogram

หมวด	รหัส	คำอธิบาย	อัตรา
9	51120	ค่าตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ 1 (มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจทั้งคืน)	ตามจริงไม่เกิน 7,000
	51121	ค่าตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ 2 (การตรวจวัดเหมือนการตรวจชนิดที่ 1 เว้นแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจ)	ตามจริงไม่เกิน 6,000

ตารางที่ 2 รหัสและอัตราการเบิก เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (CPAP)

หมวด	รหัส	คำอธิบาย	อัตรา
2	3012	เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า	20,000

ตารางที่ 3 รหัสและอัตราการเบิก หน้ากากครอบจมูก

หมวด	รหัส	คำอธิบาย	อัตรา
2	3013	หน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า	4,000

5. เอกสารตอบรับ Statement และค่าขอเบิก

- เอกสารตอบรับ แสดงรายการตามเอกสารตอบรับผู้ป่วยนอกปกติ
- Statement แสดงใน Statement ผู้ป่วยนอกปกติ และฉบับ "ผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับและจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า"
- ค่าขอเบิก สถานพยาบาลจัดทำใบค่าขอเบิก ผ่านโปรแกรม MKClaim
- การจ่ายเงิน สำนักงานประกันสังคม จ่ายให้กับสถานพยาบาลตามสิทธิ





ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม
เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีการรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหุดหทัยใจขณะหลับและมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure : CPAP) ให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน ตามมติคณะกรรมการการแพทย์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม (ชุดที่ ๑๓) ในการประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการการแพทย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (ข) ใน (๒) ของข้อ ๕ หมวด ๑ แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

“(ข) การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหุดหทัยใจขณะหลับ ดังนี้

(๑) ค่าตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ ๑ (มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจทั้งคืน) จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๗,๐๐๐ บาท

(๒) ค่าตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ชนิดที่ ๒ (การตรวจวัดเหมือนการตรวจชนิดที่ ๑ เว้นแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามขณะตรวจ) จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure : CPAP) และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาในอัตราที่สำนักงานกำหนด ดังนี้

รหัส อุปกรณ์	ประเภท	หน่วย	ราคา (บาท)
๓๐๑๒	เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure : CPAP) ลักษณะ เป็นเครื่องเพิ่มความดันอากาศในทางเดินหายใจ เพื่อให้ความดันอากาศในทางเดินหายใจเป็นบวกตลอดเวลา สามารถปรับแรงดันได้ ใช้ร่วมกับหน้ากากครอบจมูกหรือปาก แต่ละชุดประกอบด้วยตัวเครื่องหน้ากาก ท่อต่อและอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วนพร้อมใช้งานได้ ในการเบิกจ่ายเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ประกอบด้วยทุกข้อดังต่อไปนี้ ข้อบ่งชี้ ๑. สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับที่รักษาด้วยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลหรือไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดที่ไม่ซับซ้อนหรือผ่าตัดแล้วไม่ได้ผล ทั้งนี้ผู้ป่วยต้องมีระดับความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งดูจาก Apnea-hypopnea Index (AHI) ที่ได้จากการวัดด้วยวิธี Full polysomnography ในการตรวจการนอนหลับ ดังนี้ (ข้อใดข้อหนึ่ง) ๑) AHI มากกว่า ๑๕ ครั้งต่อชั่วโมง ๒) AHI ระหว่าง ๕ ถึง ๑๕ ครั้งต่อชั่วโมง แต่มีโรคประจำตัวที่อาจเลวลงจากภาวะหยุดหายใจ ขณะนอนหลับ ได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความดันโลหิตสูงหรือโรคหลอดเลือดสมอง ๒. ใบรายงานผลตรวจการนอนหลับที่มีการลงนาม โดย (ข้อใดข้อหนึ่ง) ๑) แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติการนอนหลับจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ หรือกุมารแพทย์ หรือ โสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ๒) แพทย์ที่ผ่านการสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย ๓) แพทย์ที่ผ่านการสอบประกาศนียบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประกาศนียบัตรเวชศาสตร์การนอนหลับหรือเทียบเท่า หลักสูตรอย่างน้อย ๑ ปี จากสถาบันฝึกอบรม หรือสมาคมหรือราชวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ๓. ใบรับรองแพทย์โดยแพทย์สาขาที่สามารถสั่งเบิกเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า มีดังนี้ - อายุรแพทย์การนอนหลับ/โรกระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรกระบบการหายใจ/สาขาประสาทวิทยา - กุมารแพทย์การนอนหลับ/โรกระบบการหายใจและภาวะวิกฤต	ชุดละ	๒๐,๐๐๐

รหัส อุปกรณ์	ประเภท	หน่วย	ราคา (บาท)
	โรคระบบการหายใจ/สาขาประสาทวิทยา - โสต ศอ นาสิกการนอนหลับ/โสต ศอ นาสิก - จิตแพทย์การนอนหลับ ในการเบิกเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (ในครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป) เพิ่มทุกข้อ ดังต่อไปนี้ ๑. ในกรณีเครื่องเสียซ่อมไม่ได้ โดยแนบใบยืนยันจากบริษัท และให้เปลี่ยนได้ทุก ๕ ปี ๒. แนบเอกสารยืนยันว่ามีการใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า เฉลี่ยอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง/วัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ในระหว่างที่มีการใช้งานอย่างน้อย ๓ เดือน		
๓๐๑๓	หน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ข้อบ่งชี้ สำหรับผู้ป่วยที่ใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure : CPAP) คุณสมบัติของแพทย์ผู้สั่งใช้ ๑. อายุรแพทย์การนอนหลับ/โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต โรคระบบการหายใจ/สาขาประสาทวิทยา ๒. กุมารแพทย์การนอนหลับ/โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต โรคระบบการหายใจ/สาขาประสาทวิทยา ๓. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโสต ศอ นาสิก อายุรแพทย์สาขาประสาทวิทยา ๔. จิตแพทย์การนอนหลับ ในการเบิกจ่ายหน้ากากครอบจมูกและ/หรือปาก ที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศ ขณะหายใจเข้า (ในครั้งที่ ๒ เป็นต้นไป) ประกอบด้วย ทุกข้อ ดังต่อไปนี้ ๑. ในกรณีที่ใช้ทดแทนกรณีหน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้อยู่ ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ โดยเบิกได้ไม่เกิน ๑ ชิ้น/ปี ๒. แนบเอกสารยืนยันว่ามีการใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า เฉลี่ยอย่างน้อย ๔ ชั่วโมง/วัน เป็นระยะเวลาอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ในระหว่างที่มีการใช้งานอย่างน้อย ๓ เดือน	ชิ้นละ	๔,๐๐๐

ทั้งนี้ ค่าอุปกรณ์เสริม รายการแผ่นกรองอากาศ (Filter) กระดาษ และแผ่นกรองอากาศ (Filter) ฟองน้ำ ให้รวมอยู่ในค่าบริการทางการแพทย์ของสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน”

ข้อ ๓ กรณีสถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน ส่งตัวผู้ประกันตนไปรักษายังสถานพยาบาลอื่น โดยผู้ประกันตนได้รับการตรวจวินิจฉัยและอนุมัติเบิกใช้ เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า (Continuous Positive Airway Pressure : CPAP) ให้สถานพยาบาลที่กำหนดสิทธิ ในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนจ่ายค่าบริการทางการแพทย์พร้อมค่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่สถานพยาบาลที่ทำการรักษา โดยสามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์พร้อมค่าอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค ตามหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการที่สำนักงานกำหนดตาม ข้อ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พลตำรวจโท



(ธนา ชูระเจน)

ประธานกรรมการการแพทย์